

Fecha Última Actualización: 18-11-2022 12:37:38

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Alfonso Enrique Romero Boscan
Edad : 32a 4m 5d
Dirección : Pasaje Aguacate 3769

Rut : 41.207.652-4
Fecha Nacto: 11/07/1990
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2211693
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 3770 6146

N° Epicrisis
314800

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim (5to Piso Mater)

Fecha Ingreso : 10/06/2022 02:25

Días Estadía: 159

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 16/11/2022 12:00

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Paro Cardíaco Con Resucitación Exitosa

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Datos del Paciente

Nombre : Alfonso Romero Boscan

Edad : 32 años

RUT : 41207652-4

FI HUAP : 23-02-22

FI HSR : 10-06-22

FI UTIM 4° (1°) : 10-06-22

FI UPC (1°) : 07-07-22

FI UTIM (2°) : 19-07-22

FI Sala : 03-08-22

FI UTIM (3°) : 19-08-22

FI UPC (2°) : 24-08-22

FI UTIM (4°) : 12-09-22

Antecedentes:

Médicos:

-ERC estadio V en hemodiálisis

oMonorreno congénito

-Malaria tratada 2018

Quirúrgicos: Apendicectomía

Fármacos: desconoce

Alergias: no

Hábitos: OH (-) TBQ (-) Otras drogas (THC ocasional)

Motivo de Ingreso: traslado desde UPC

Anamnesis Próxima: paciente con hospitalización prolongada, se realiza resumen operativo

Hospitalizado en HUAP por ITS CVC por SAMS, terapia incompleta por fuga del paciente.

Re ingresa en EPA requiriendo VMI, completó 21 días en VMI. Durante estadía habría presentado PCR con AESP y FV, logra ROSC tras 10 minutos, presentó sd convulsivo y se describe secuela con sd pancerebeloso.

Presentó además trombosis de catéter tunelizado con extensión a AD y VD requiriendo trombectomía mecánica (12-03), ITS

Fecha Epicrisis : 18/11/2022 12:37

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 18-11-2022 12:37:38

Página 2 de 4

CVC por Ps aeruginosa MS y neumonía por COVID19

Se traslada a CASR para continuar rehabilitación, presentó y por planes

Hemodinamia-Cardiológico: En contexto de múltiples interurrencias infecciosas ha requerido apoyo con DVA. Durante tercera hospitalización en UTIM presentó episodio de bradicardia extrema sintomática que requirió manejo con parches de marcapasos, dopamina, noradrenalina y adrenalina, una vez resueltos perpetuadores (sepsis e Hiperkalemia) reseuñe el conflicto. Durante última estadía en UPC se describe sin nuevas interurrencias. Se habría realizado estudio con EcoTT por equipo UCO el 05-09 que no evidenció vegetaciones. Durante estadía en UTIM con caídas de Hb requiriendo TR UGR, actualmente Hcto/Hb 7.0, pero en manejo con EPO y HDN estable, sin exteriorización de sangrado, terapia Tx restrictiva según síntomas.

Respiratorio: Requirió intubación en dos ocasiones. En la primera ocasión en relación a agitación requiriendo ventilación por 3 días (julio) y segunda ocasión en relación a shock cardiogénico por bradicardia extrema sintomática (agosto). En el curso precoz de dicha intubación y en relación a desplazamiento de tubo orotraqueal presentó atelectasia masiva LID° y NAVM requiriendo maniobra de prono por 1 día. Dado VMI prolongada se realizó TQT percutánea el 06-09 sin incidentes. Actualmente TQT percutánea por VMI prolongada. En rehabilitación, sin falla respiratoria. No conectar a VMI.

Infeccioso: Presentó múltiples HITs infecciosos, se incluyen los presentados en HUAP:

- ITS CVC SAMS, tras fuga y re ingreso habría completado terapia con vancomicina EV

- ITS CVC por Ps aeruginosa, completó esquema con meropenem 9 días

- Sospecha de alveolitis vs absceso dental, completó 5 días de ampicilina-sulbactam

- ITS asociada a nuevo CHD tunelizado por SAMS, retirado el 07-06. Completó 14 días desde HC de control negativo del 10-06. EcoTE sin compromiso endocárdico, cintigrama óseo 20-06 sin compromiso óseo.

- Sd diarreico agudo por CD, completó 14 días de vancomicina

- ITS CVC de medicamentos por SAMS (cultivo punta CVC 20-08, retiro ese día). Completó nuevo curso de antibioterapia con cloxacilina suspendido a los 13 días como sugerencia de infectología tras hallazgos de EcoTT 05-09. Se describe en TC de tórax 25-08 nódulos cavitados pulmonares bilaterales sospechosos de embolias sépticas.

- NAVM por PS aeruginosa (S) aminoglucosidos y colistin y K pneumoniae MS, recibe imipenem y ciprofloxacino completando esquema inicial y re iniciado tras persistencia de agentes en CAET del 03-09, completando 6 días de terapia previo al traslado desde UPC

- 2° episodio de diarrea por CD, se mantiene recibiendo vancomicina oral en día 14 al momento de traslado desde UPC.

Lo último recibido fue Tigeciclina (en contexto de infección de sitio de celulitis química) y Vancomicina oral como profilaxis (2 episodios de diarrea por CD).

Dado pronóstico del paciente, sin mayor beneficio de terapia antibiótica, se determinó con equipo de infectología suspensión de estos, con plan de no tomar más cultivos ni iniciar nueva cobertura antibiótica.

Se mantiene con síndrome febril persistente, solo con manejo sintomático.

Nefrológico: Paciente con ERC, cronicado desde Julio/22, HD trisemanal (M-J-S). El 08/11 se reinstala CHD dado que eus e encontraba desplazo. Hoy retoma diálisis, tiene otra sesión mañana. Seguimiento diario de ELP y BUN.

Quirúrgico: Presentó episodio de obstrucción intestinal por bridas requiriendo liberación de adherencias (16-07). Posteriormente y tras sufrir celulitis química requirió escarectomía el 11-09 de lo que egresa con VAC. Considerando mal pronóstico en términos de rehabilitación, se mantendrá VAC en dorso de pie derecho, curaciones avanzadas en úlceras occipital, sacra y trocántica. Último cambio de VAC de UPP dorsal pie derecho fue el 02/11.

Neurológico: Se describe desde HUAP con sd. pancerebeloso post PCR, RM no compatible con encefalopatía hipóxica isquémica, sin embargo realizada fuera de ventana, se mantiene manejo con Amandatina indicado por neurología. Además presentó episodio convulsivo durante estadía en HUAP, por lo que se ha mantenido en manejo con ácido valproico. Durante estadía en UPC no se describen eventos convulsivos.

Metabólico: durante estadía en UTIM y en relación a shock séptico-cardiogénico presentó hipoglicemia severa sintomática. Durante estadía en UPC no se describen nuevos eventos.

En suma se traslada a UTIM para continuar rehabilitación multimodal, consolidar weaning y continuar terapia antimicrobiana

Gastroenterológico: durante hospitalización presentó HDA en dos ocasiones, EDA 08-08 con candidiasis esofágica y úlcera

Fecha Epicrisis : 18/11/2022 12:37

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 18-11-2022 12:37:38

Página 3 de 4

duodenal, EDA 19-08 con úlcera FIII recibiendo IBP.

Diagnósticos:

Poli neuropatía del paciente crítico
Insuficiencia respiratoria en regresión
- TQT percutánea 06-09
- VMI prolongada (marzo 21 días, julio 3 días, agosto hasta septiembre 22 días)
NAVM por K pneumoniae y Ps aeruginosa
Nódulos pulmonares cavitados obs embolias sépticas.
Diarrea por CD (segundo episodio)
Hipoglicemia severa
Disfagia
Celulitis química EID° - escarectomía 11-09 - sospecha de foco primario de bacteremia por SAMS
Sd pancerebeloso y atetosis secundaria
Anemia N-N multifactorial
LPP glútea ° G3

Resueltas

PCR AESP - FV (ROSC 10 min) marzo 2022 - VMI 06-03 a 27-03
Candidiasis esofágica leve tratada (Kodsi 1) EDA 08-08
Sd diarreico agudo por C difficile primer episodio
Obstrucción intestinal mecánica por bridas
- Laparotomía exploradora + liberación de adherencias (16/07)
- Ileo adinámico resuelto
EPA - VMI 07 al 10-07
ITS CVC por SAMS (tres episodios)
ITS CVC por Ps aeruginosa (junio)
Bradycardia extrema - shock cardiogénico resuelto
HDA resuelta
- EDA 08-08 úlcera duodenal y Candidiasis esofágica
- EDA 19-08 úlcera forrest 3 en segunda porción del duodeno, sospecha de angioplastías en cuerpo bajo y antro sin sangrado activo
Delirium hiperactivo de difícil manejo
- Primoconvulsión en estudio
- Encefalopatía hipóxica isquémica

Se traslada a sala básica con siguiente plan:

No RCP y no conectar a ventilador mecánico. HD programadas (actualmente Lu-Mi-Vi). Pronóstico reservado, pobre expectativa en términos de rehabilitación determinado por malas condiciones basales de paciente (mielolisis pontina, desnutrición calórico-proteica severa, mioneuropatía de paciente crítico, múltiples hits infecciosos por microorganismos resistentes). Por ahora énfasis en medidas de confort. Seguimiento por equipo de paliativos no oncológicos para titulación de analgesia.

Durante el fin de semana del 11-14 de noviembre evoluciona febril, decidiéndose no cubrir con ATB ni cultivar dado condiciones ya descritas. El Lunes 15/11 AM evoluciona con disfunción del CVC de diálisis. Se conversa con familiares y se decide optar por medidas de confort y no reinstalar nuevo CVC de HD, quedando sin TRR. El día miércoles 16/11 fallece aprox a las 12:00.

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Asociada A Ventilación Mecánica (Navm) - Kpn Blee - Psae Mr

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

--

Fecha Epicrisis : 18/11/2022 12:37

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:02

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Indicaciones

Tipo de Reposo : Cabeza Línea Media 30°

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Camilo San Martín Ojeda
Becado/Residente



Sebastián Oksenberg Sharim
Médico Tratante (Staff)